

SenaMUN V

Organização Mundial da Saúde



Serviço De Aprendizagem Comercial

Senac | Ensino Médio Técnico

Vice Mesário(a)
Hadassah Coimbra

Mesário(a) Principal
Isabella Cordeiro

Vice Mesário(a)
Mariana Marques

SUMÁRIO

Carta de Boas-Vindas.....	3
1. INTRODUÇÃO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.....	4
2. Tópico: Discutindo mecanismos para garantir a saúde integral das mulheres em um mundo desigual.....	5
2.1 Questões Norteadoras:.....	5
3. CONTEXTO GERAL.....	6
4. CONTEXTO HISTÓRICO.....	7
4.1. Contexto Histórico dos Direitos das Mulheres.....	7
4.2. Patriarcado e Exclusão Feminina.....	7
4.3. Movimentos Sufragistas.....	7
4.4. Direito ao Voto e à Educação.....	8
4.5. Primeiras Reivindicações sobre Saúde Feminina.....	8
4.6. Saúde da Mulher e os Movimentos Feministas.....	8
4.7. Segunda Onda Feminista.....	9
4.8. Direitos Reprodutivos.....	9
4.9. Contracepção e Planejamento Familiar.....	10
4.10 Denúncia de Abusos Médicos.....	10
5. AÇÕES ANTERIORES DA ONU.....	11
6. SITUAÇÃO ATUAL.....	12
7. POSIÇÃO GERAL DOS PRINCIPAIS MEMBROS.....	13
8. EVENTOS E ATOS HISTÓRICOS.....	19
9. LISTA DE PAÍSES.....	23
10. REFÊRENCIAS.....	24

Carta de Boas-Vindas

Honoráveis delegações,

É com grande honra e um imenso prazer que suas mesárias vem por meio desta carta desejar-lhes as mais sinceras boas-vindas ao comitê da OMS da V edição do SenaMUN! Somos Isabella Cordeiro, Hadassah Coimbra e Mariana Marques e estamos ansiosas para sermos suas mesárias nesta conferência.

Prezados delegados, sou Isabella Cordeiro e com satisfação serei a Head-Chair deste comitê que aborda um tema tão relevante em nossa sociedade. Estou cursando o terceiro ano do ensino médio no SENAC Nações Unidas e o início de minha trajetória nas simulações aconteceu durante meu primeiro ano na oficina de debates. Tenho certeza de que os debates darão oportunidades a diálogos potentes e bem estruturados, assim, desejo aos senhores uma vivência enriquecedora e marcada pelo respeito, cooperação e construção de soluções inovadoras. Nos vemos em breve e desejo a todos uma excelente simulação!

Caros delegados, Meu nome é Hadassah Coimbra, e terei a honra de ser a co-chair de vocês neste comitê. Atualmente, curso o Ensino Médio Técnico em Administração no Senac Nações Unidas, mas minha história com as simulações se iniciou durante o primeiro ano, e foi nesse período que as simulações tomaram espaço na minha vida e no meu coração. Desejo que os delegados tenham uma experiência ótima nessa nova edição do SenaMUN e mal posso esperar para vê-los debatendo um tema tão sensível quanto este.

Honoráveis delegados, me chamo Mariana Marques, e terei a honra de ser co-chair de vocês neste comitê incrível! Sou estudante do segundo ano do ensino médio no Colégio Militar em São Paulo, e foi numa Organização Mundial da Saúde que eu me encontrei nesse mundo incrível das simulações. Esse comitê sempre terá um espaço especial no meu coração e espero que, junto com minhas companheiras de mesa, possamos fazer com que a OMS também tenha um espaço especial no coração de vocês. Espero que os senhores tenham uma experiência excepcional nessa edição do Sena MUN e conto as horas para vê-los debatendo.

Torcemos para que os delegados tenham uma experiência maravilhosa, que lhes proporcione muito conhecimento, lhes dê espaço para desenvolverem suas habilidades e estimule seu senso crítico. Nosso objetivo é criar um espaço aberto à diplomacia, um debate produtivo, respeitoso e apropriado para todos.

Qualquer dúvida podem nos contatar nos seguintes emails:

hadassahnello@gmail.com

isacordeiro73@gmail.com

urupinha@gmail.com

Atenciosamente,

Isabella Cordeiro, Hadassah Coimbra e Mariana Marques.

1. INTRODUÇÃO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE



A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a principal agência das Nações Unidas voltada à saúde pública internacional. Ela se estabelece como uma instituição que visa melhorar a saúde global como um todo. Seus inúmeros contatos diretos com governos tornam mais eficaz a atuação do órgão em escala mundial.

Conforme destacado pela própria OMS: “A saúde é um direito humano; chegou o tempo da saúde para todos. Para tornar a saúde para todos uma realidade, é preciso que as pessoas, individualmente e em comunidade, tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, de modo que possam cuidar de sua própria saúde e da saúde de suas famílias.”

A OMS atua como um órgão técnico e consultivo, fornecendo orientações baseadas em evidências científicas. Além disso, a organização define padrões e diretrizes para a atuação dos serviços de saúde nos Estados-membros. Ademais, a OMS realiza o monitoramento contínuo do cenário sanitário global, abrangendo o bem-estar da população mundial. De igual forma, a instituição media debates entre as nações participantes, com o objetivo de identificar soluções mais efetivas e viáveis para a implementação de políticas e projetos em saúde, os quais também são definidos nesses fóruns de discussão.

2. Tópico: Discutindo mecanismos para garantir a saúde integral das mulheres em um mundo desigual.

2.1 Questões Norteadoras:

- 1) De que maneira o conceito de "saúde integral" vai além da perspectiva estritamente reprodutiva e materna para abranger o bem-estar físico, social e mental?
- 2) Como a interseccionalidade entre gênero, raça e classe intensifica as vulnerabilidades no acesso aos serviços de saúde?
- 3) De que forma a sobrecarga do trabalho de cuidado não remunerado afeta a longevidade e a saúde feminina ao longo da vida?
- 4) Quais estratégias reduzem efetivamente a mortalidade materna em cenários de extrema pobreza ou conflitos armados?
- 5) Qual é o impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre a segurança, a saúde e o bem-estar das mulheres vulneráveis?

Figura 2: Mulheres e crianças na região afetada pelo furacão Matthew em Damassins, Haiti. No país, 69 em cada mil crianças nascidas vivas morrem antes dos 5 anos.



Fonte: G1, 2016.

3. CONTEXTO GERAL.

Promover a saúde integral das mulheres é uma prioridade no contexto das políticas públicas globais, especialmente em um mundo marcado por profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. Durante muito tempo, a saúde da mulher foi tratada de forma limitada, sendo associada quase exclusivamente à maternidade ou à ausência de doenças. Essa visão reducionista desconsiderava diversos aspectos fundamentais da vida feminina, como o bem-estar mental, social e o acesso equitativo a serviços de saúde. Segundo a OMS, cerca de 287 mil mulheres morreram em 2020 por causas relacionadas à gravidez e ao parto, sendo a maioria dessas mortes considerada evitável.

A saúde integral, conforme definida pela OMS, não se resume apenas à ausência de enfermidades, mas envolve um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, é necessário compreender a mulher em todas as fases da vida — infância, adolescência, idade adulta e envelhecimento, reconhecendo que cada etapa apresenta demandas e desafios específicos, especialmente quando atravessadas por contextos de desigualdade.

Atualmente, observa-se um avanço nas políticas públicas, que passam a adotar uma abordagem mais ampla e inclusiva da saúde feminina. Organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) têm reforçado a importância de garantir acesso universal à saúde, considerando não apenas o período gestacional, mas todas as dimensões da vida das mulheres. Ainda assim, milhões de mulheres ao redor do mundo enfrentam dificuldades no acesso a serviços básicos de saúde, especialmente em regiões mais vulneráveis. Dados da ONU Mulheres apontam que aproximadamente 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual ao longo da vida, fator que impacta diretamente a saúde física e mental feminina.

No que diz respeito à saúde física, é importante considerar aspectos naturais do corpo feminino, como a menstruação, a gestação e a menopausa, além da necessidade de prevenção e tratamento de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Segundo a OMS, o câncer de mama é atualmente o tipo de câncer mais diagnosticado entre mulheres no mundo. No entanto, essas questões são frequentemente agravadas pela falta de acesso a informações, exames e tratamentos adequados, principalmente em países em desenvolvimento.

Dessa forma, a saúde integral das mulheres deve ser entendida como um conjunto de cuidados que envolvem não apenas o corpo, mas também a mente e as condições de vida. Garantir esse direito exige ações coordenadas entre governos, organizações internacionais e sociedade civil, com foco na redução das desigualdades e na promoção da equidade.

4. CONTEXTO HISTÓRICO.

4.1. Contexto Histórico dos Direitos das Mulheres.

Segundo a ONU Mulheres, no ano de 2024, um entre quatro países relatou retrocessos nos direitos das mulheres. As vítimas dessas medidas enfrentam restrições significativas ao acesso à saúde básica, que vão muito além da falta de hospitais ou medicamentos. Muitas vezes, esse regresso é agravado por barreiras sociais e culturais que limitam a autonomia feminina, como a dificuldade de decidir sobre a contracepção ou de recusar relações sexuais, comprometendo diretamente a saúde reprodutiva.

Nesse sentido, já no século XVIII, a filósofa Mary Wollstonecraft defendia que, apesar das diferenças biológicas entre homens e mulheres, tais distinções não implicavam inferioridade intelectual feminina. Ao lado da dramaturga francesa e ativista Olympe de Gouges, Wollstonecraft denunciou a exclusão das mulheres da cidadania e defendeu o direito à educação e ao cuidado com a saúde. Esses marcos iniciais revelam como fatores sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais comprometem o acesso à saúde básica, atingindo de forma desigual diferentes populações.

Em contrapartida, mulheres pobres, indígenas e negras enfrentam barreiras adicionais, como falta de recursos financeiros, distância geográfica, discriminação cultural e institucional, além das desigualdades de gênero, que resultam em diagnósticos tardios, aumento da mortalidade materna e infantil e perpetuação da exclusão social.

4.2. Patriarcado e Exclusão Feminina.

A garantia dos direitos básicos às mulheres permanece um tema complexo, pois se insere em uma sociedade patriarcal consolidada ao longo de décadas. Essa estrutura reforçou a ideia de que o homem ocupa o espaço público e de poder, enquanto a mulher deveria se restringir ao espaço privado, subordinada às funções domésticas e familiares. Como consequência, as mulheres foram historicamente excluídas de oportunidades fundamentais, como o acesso à educação, à participação política e ao mercado de trabalho em condições de igualdade. A luta feminista surge como resposta a esse cenário, buscando desconstruir padrões patriarcais e abrir espaço para que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos plenos de direitos, capazes de transformar todos os âmbitos da vida social.

4.3. Movimentos Sufragistas.

Essa resistência se intensificou com os movimentos sufragistas, que desempenharam papel fundamental na luta pelos direitos das mulheres, especialmente a partir do final do século XIX e início do século XX. As reivindicações não se limitavam ao direito ao voto, mas também incluíam melhores condições de vida, educação e acesso à saúde básica. Organizadas em diversos países da Europa e das Américas, as sufragistas denunciaram desigualdades estruturais que mantinham as mulheres em situação de vulnerabilidade, sobretudo na saúde materna e

infantil. Entre os principais movimentos, destacam-se a Women's Social and Political Union (WSPU), fundada no Reino Unido por Emmeline Pankhurst em 1903, e a National American Woman Suffrage Association (NAWSA), nos Estados Unidos, criada em 1890. Esses grupos organizaram protestos, campanhas e atos públicos que denunciaram as desigualdades e abriram caminho para conquistas posteriores.

4.4. Direito ao Voto e à Educação.

Com o avanço das ideias de igualdade e cidadania, especialmente no século XX, a educação feminina passou a ser vista como direito fundamental. Durante o século XIX, surgiram leis e reformas educacionais que incluíam meninas no ensino primário, ainda que com conteúdos voltados ao trabalho doméstico. No Brasil, o direito ao estudo e ao voto para as mulheres ocorreu de forma tardia. A Lei Geral de Ensino de 1827, promulgada no período imperial, foi um marco importante, determinando a criação de escolas de primeiras letras em cidades e vilas, garantindo oficialmente o acesso das meninas à educação básica, ainda que de forma limitada. Após a Segunda Guerra, organizações internacionais como a ONU e a UNESCO passaram a defender a universalização do ensino básico para meninos e meninas, reconhecendo a educação como essencial para o desenvolvimento social e econômico.

4.5. Primeiras Reivindicações sobre Saúde Feminina.

Paralelamente às conquistas educacionais e políticas, surgiram as primeiras reivindicações sobre saúde feminina entre o século XIX e o início do século XX. Mulheres passaram a questionar a exclusão de suas necessidades específicas dos sistemas de saúde e das políticas públicas, exigindo atendimento digno durante a gestação e parto, redução da mortalidade materna e infantil e acesso a médicos e hospitais em condições adequadas. Com o avanço dos movimentos feministas, sobretudo a partir da década de 1960, essas demandas se ampliaram para incluir o direito à contracepção, ao planejamento familiar e ao aborto seguro, como parte da autonomia sobre o próprio corpo.

Nesse contexto, também se denunciou a medicalização excessiva que reduzia a mulher à função reprodutiva, ignorando outras dimensões de sua saúde física e mental. A luta passou a englobar o combate à violência obstétrica, a defesa de políticas de prevenção e tratamento de doenças como câncer de mama e de colo do útero, e a exigência de pesquisas médicas que considerassem diferenças biológicas e sociais entre homens e mulheres, consolidando a saúde feminina como campo de direitos e cidadania.

4.6. Saúde da Mulher e os Movimentos Feministas.

A saúde da mulher e os movimentos feministas se conectam em diferentes momentos históricos e países, mostrando como a luta pela igualdade se expandiu para o campo da saúde.

No Brasil, o pioneirismo coube ao Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado em 1983, que propôs uma abordagem holística para a saúde

feminina e inspirou os futuros princípios do SUS ao incluir os direitos sexuais e reprodutivos. No cenário europeu, destacam-se tanto iniciativas nacionais quanto regionais: o *National Health Service* (NHS) do Reino Unido, fundado em 1948, consolidou na década de 1990 reformas que fortaleceram o atendimento direcionado às mulheres; no mesmo período, em âmbito continental, o *European Women's Lobby* (EWL) foi instituído em 1990 como a maior coalizão feminina da Europa, articulando milhares de associações na defesa da igualdade de gênero.

Esses marcos revelam como a luta feminista pela saúde e pelos direitos das mulheres se deu em diferentes frentes, consolidando-os como parte essencial da cidadania e da igualdade de gênero.

4.7. Segunda Onda Feminista.

Durante a segunda onda feminista, entre as décadas de 1960 e 1980, o movimento ampliou suas pautas para além do sufrágio, incorporando debates sobre sexualidade, trabalho, saúde reprodutiva e igualdade racial.

Nesse contexto, Audre Lorde e Shirley Chisholm se destacaram como lideranças fundamentais. Lorde, poeta e ensaísta, introduziu a perspectiva interseccional ao denunciar como raça, gênero e sexualidade se entrelaçaram na opressão das mulheres negras e lésbicas, além de transformar sua experiência com o câncer em militância política. Já Chisholm, primeira mulher negra eleita para o Congresso dos EUA em 1968 e candidata à presidência em 1972, utilizou sua posição para defender o Equal Rights Amendment e denunciar a exclusão das mulheres pobres e negras dos serviços médicos. Ao lado de outras lideranças, elas ajudaram a consolidar a ideia de que a luta feminista não se restringia à igualdade formal, mas também à conquista de condições concretas de vida e dignidade, influenciando debates internacionais e conferências da ONU que reconheceram a saúde reprodutiva e básica como direitos humanos universais.

4.8. Direitos Reprodutivos.

A partir dessas conquistas, os direitos reprodutivos das mulheres e o acesso à saúde básica passaram a ser reconhecidos internacionalmente como pilares dos direitos humanos. Esses direitos englobam a possibilidade de decidir livremente sobre quando e quantos filhos ter, o acesso a métodos contraceptivos, ao aborto seguro onde legalizado, à prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e à educação sexual de qualidade.

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo (1994) e a Plataforma de Ação de Pequim (1995) foram marcos globais ao consolidar a saúde reprodutiva como parte essencial da cidadania e da igualdade de gênero. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça que a cobertura universal de saúde deve incluir serviços básicos para mulheres, como pré-natal, parto seguro, cuidados pós-parto e prevenção de câncer ginecológico.

Diante do exposto, no entanto, persistem desigualdades, sobretudo em regiões da África, Ásia e América Latina, onde barreiras econômicas, culturais e legais ainda limitam esse direito.

4.9. Contracepção e Planejamento Familiar.

Nesse cenário, a contracepção e o planejamento familiar tornaram-se elementos centrais para a saúde e a autonomia das mulheres em todo o mundo. O acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes permite que cada mulher decida quantos filhos deseja ter, garantindo liberdade reprodutiva e fortalecendo sua participação na sociedade. Entre os métodos disponíveis estão opções hormonais, dispositivos intrauterinos, preservativos e procedimentos definitivos, cada um com características próprias que se adequam a diferentes necessidades. O impacto social do planejamento familiar é profundo, pois reduz gestações não planejadas e contribui para a diminuição da mortalidade materna.

4.10 Denúncia de Abusos Médicos.

Os relatos de abusos médicos contra mulheres em diferentes partes do mundo expõem práticas de negligência, violência obstétrica e desrespeito à autonomia feminina, revelando como muitas vezes seus corpos são tratados sem consentimento ou dignidade. Essa realidade se agrava diante das barreiras que ainda limitam o acesso à saúde básica, especialmente em regiões marcadas pela pobreza e desigualdade, onde consultas ginecológicas, métodos contraceptivos e acompanhamento pré-natal não são garantidos de forma universal.

A ausência de políticas públicas eficazes e de sistemas de saúde acessíveis perpetua vulnerabilidades, tornando urgente assegurar às mulheres não apenas proteção contra abusos, mas também o direito pleno a cuidados de saúde de qualidade, seguros e respeitosos, como condição essencial para a justiça social e a igualdade de gênero.

5. AÇÕES ANTERIORES DA ONU.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já vem participando de debates relacionados à segurança e à saúde das mulheres desde 1995. Desde então, medidas estão sendo tomadas para assegurar que as mulheres do mundo inteiro tenham acesso à saúde. Hoje em dia, a OMS deu continuidade a essas discussões e transformou essas discussões em ações práticas, focando muito em direitos reprodutivos, igualdade de gênero e no fim de preconceitos históricos que ainda pesam na vida de muitas mulheres.

Na prática, uma das maiores bandeiras da OMS agora faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. O foco principal é garantir que qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo, tenha acesso a planejamento familiar, informação e serviços de saúde sexual. Existe um esforço gigante para derrubar os índices de mortalidade materna. Para isso, a organização investe significativamente na capacitação de parteiras e médicos, no fortalecimento de hospitais em regiões mais vulneráveis, como a África Subsaariana e o Sul da Ásia, garantindo que o pré-natal e o parto sejam seguros.

As diretrizes atuais buscam preparar os hospitais e postos de saúde para serem espaços efetivos de acolhimento. A ideia é capacitar os profissionais para identificar sinais de abuso, dar suporte psicológico imediato e tratar as sequelas físicas de forma humanizada.

Além disso, as ações atuais olham muito para as doenças que mais matam mulheres hoje, como o câncer de mama e o de colo do útero. Com iniciativas globais recentes, a meta é expandir a vacinação contra o HPV nas escolas e facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento em países mais pobres, onde o acesso à mamografia e aos exames de rotina ainda é muito difícil.

É perceptível que a ONU e a OMS entenderam que a saúde da mulher vai muito além de tratar doenças. Tem a ver com o bem-estar mental, social e, acima de tudo, com autonomia. Colocar a igualdade de gênero no centro da saúde é uma forma de garantir que as mulheres tenham voz e controle sobre as suas próprias escolhas.

6. SITUAÇÃO ATUAL.

Falar sobre a saúde integral das mulheres hoje é reconhecer uma realidade de contrastes. Por um lado, organismos como a OMS têm reforçado cada vez mais que cuidar da mulher significa olhar para todas as fases da sua vida, e não apenas para o período de gravidez ou maternidade. Mas, por outro lado, a prática ainda mostra que enfrentamos algumas barreiras. Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis, como os problemas cardiovasculares e os cânceres de mama e do colo do útero, são as principais causas de adoecimento e morte feminina no mundo. Entretanto, bilhões de mulheres ainda não têm acesso a exames simples de rotina para diagnosticar essas condições a tempo.

Ao mesmo tempo, vivenciamos uma crise silenciosa, mas extremamente grave, na saúde mental. As mulheres enfrentam taxas significativamente mais altas de ansiedade e depressão, um reflexo direto da sobrecarga do dia a dia, da jornada dupla ou tripla de trabalho e do peso invisível do cuidado não remunerado com a família e a casa. Essa conta chega na forma de exaustão e burnout. Para além disso, a saúde materna continua sendo um desafio doloroso, pois a maioria das complicações no parto e no pós-parto ainda ocorre por falta de estrutura básica em regiões que são muito mais vulneráveis, causando mortes que poderiam ser evitáveis.

Tudo isso se intensifica quando olhamos para as desigualdades sociais. Renda, raça e onde uma mulher mora definem diretamente o tipo de atendimento que ela vai receber. Garantir uma saúde verdadeiramente integral exige ir além dos consultórios: passa por criar redes de apoio para a saúde mental, facilitar o acesso a diagnósticos precoces, oferecer suporte reprodutivo digno e combater as desigualdades financeiras e sociais que impedem as mulheres de priorizarem o próprio bem-estar.

7. POSIÇÃO GERAL DOS PRINCIPAIS MEMBROS.

EMIRADO ISLÂMICO DO AFGANISTÃO 	O Afeganistão é representado, de fato, pelas autoridades do Talibã, cujas diretrizes rejeitam as convenções dos direitos humanos ocidentais. Operando à revelia da CEDAW, debate dizendo que o bem-estar e a saúde das mulheres são integralmente resguardados dentro dos limites interpretativos da Sharia. A prioridade afegã é denunciar o congelamento de seus ativos financeiros internacionais, e seu argumento central é que a asfixia financeira extrema impede o apoio total às mães e recém-nascidos em seus hospitais.
REINO DA ARÁBIA SAUDITA 	A Arábia Saudita projeta sua imagem externa com base no plano de modernização socioeconômica Vision 2030, que aumentou exponencialmente a participação feminina na sociedade e no mercado de trabalho. A nação apresenta um histórico de grande investimento em medicina, entretanto, mantém seu alinhamento com a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã. O país saudita acredita na melhoria das condições de vida das mulheres, desde que dentro da legislação islâmica e respeitando a soberania cultural.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	A nação brasileira possui uma tradição diplomática multilateral voltada principalmente para os direitos humanos e justiça social, adotando o Consenso de Montevideu sobre População e Desenvolvimento como base para sua atuação em relação às mulheres. O Brasil defende a saúde da mulher em um viés de equidade, focando nos determinantes socioeconômicos que geram as desigualdades no âmbito médico. Em termos econômicos, o Brasil lidera defendendo a flexibilização de patentes e transferência de tecnologia para países em desenvolvimento.
CANADÁ 	O Canadá atua internacionalmente pautado em sua Política de Assistência Internacional Feminista, em cumprimento do quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Historicamente, o país enxerga a saúde feminina como um pilar para o desenvolvimento econômico global. Por iniciativas como a parceria global SheDecides e as diretrizes da Plataforma de Ação de Pequim, a nação defende o fim das barreiras que

	impeçam o aborto seguro e a contracepção, contando com a cooperação multilateral.
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 	A política chinesa é rigidamente fundamentada na soberania estatal, conforme defendido na Conferência de Pequim +25. A China considera a saúde e os direitos das mulheres como consequências diretas do desenvolvimento nacional. Através da cooperação Sul-Sul, a nação foca no envio de equipes médicas e doação de insumos hospitalares sem condicionalidades políticas, entretanto, rejeita fortemente qualquer argumentação de cunho humanitário para monitoramento de suas políticas internas
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 	A diplomacia norte-americana, na saúde feminina, é historicamente pendular, alterando-se conforme o partido à frente do governo. Todavia, o país tem um legado de financiamento médico global por meio do PEPFAR, que mudou o tratamento de HIV/AIDS para as mulheres em todo o mundo. A nação estadunidense defende a inovação tecnológica e o combate à violência de gênero, mas ao mesmo tempo evita debates reprodutivos para proteger os direitos de patente de sua indústria farmacêutica.
REPÚBLICA FRANCESA 	A França promove ativamente a sua “diplomacia feminista”, consolidada durante a sua presidência do G7 e na co-presidência do Fórum Geração Igualdade em Paris. A nação tem como tradição o financiamento de grandes estruturas de saúde, contribuindo fortemente do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. Em contextos multilaterais, o país discute que os direitos médicos femininos são universais e inalienáveis, além de priorizar a proteção de mulheres refugiadas e migrantes em zonas de conflito.
REPÚBLICA DA ÍNDIA 	A política indiana no setor de saúde está intrinsecamente ligada ao seu papel de “farmácia do mundo”, posição reafirmada na Declaração de Nova Déli dos Líderes do G20. O país defende a quebra de patentes e democratização do acesso a medicamentos genéricos e vacinas para as mulheres do Sul Global. A nação promove programas voltados para o saneamento e apoio financeiro à gestação, e usa isso como guia de suas propostas, com foco em metas como higiene menstrual e saúde materna.

REPÚBLICA ITALIANA 	A Itália alinha sua diplomacia aos marcos de direitos humanos da União Europeia, sendo signatária da Convenção de Istambul contra a violência de gênero. O país possui um histórico de liderança em programas internacionais voltados para a erradicação de práticas tradicionais nocivas, como a Mutilação Genital Feminina (MGF). No entanto, o cenário político interno italiano, frequentemente influenciado por coalizões conservadoras, faz com que a delegação adote uma postura mais cautelosa em relação à universalização irrestrita do direito ao aborto. O foco do país se concentra tradicionalmente no aprimoramento da saúde materno-infantil, do acompanhamento pré-natal e do suporte social.
JAPÃO 	O Japão orienta sua política externa pelo conceito central de "Segurança Humana", estabelecido na Declaração da Cúpula do G7 de Ise-Shima, que visa proteger os indivíduos por meio da Cobertura Universal de Saúde (UHC). O país possui um longo histórico de ajuda externa técnica e financeira focada na saúde materno-infantil em nações em desenvolvimento, canalizada pela Agência de Cooperação Internacional do Japão. Tradicionalmente, a diplomacia japonesa evita debates ideológicos altamente polarizados sobre direitos reprodutivos, preferindo direcionar o foco para consensos práticos e tangíveis.
REPÚBLICA DO MALI 	O Mali enfrenta um cenário complexo de crises humanitárias e de segurança na região do Sahel, o que molda sua atuação em torno das necessidades estruturais mais básicas de sobrevivência. Embora o país seja signatário do Protocolo de Maputo da União Africana, a aplicação prática dos direitos das mulheres esbarra na escassez de recursos. A delegação traz um histórico de apelos por justiça econômica internacional e financiamento emergencial para combater a desnutrição, a malária e o HIV. O país demonstra abertura para tratar de reformas contra o casamento infantil e a MGF, desde que conduzidas por vias educacionais comunitárias e sem sanções externas.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	O posicionamento do México é fortemente influenciado por ter sido o pioneiro na América Latina a adotar uma Política Externa Feminista em 2020. A visão diplomática mexicana trata a

	violência baseada em gênero não apenas como uma pauta de segurança, mas como uma crise de saúde pública, fundamentando-se nos princípios da Convenção de Belém do Pará. O país possui um histórico de busca por equilíbrio, tentando atuar como ponte entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento para garantir financiamento sem perdas de soberania. Além disso, as discussões ambientais do Acordo de Escazú moldam a perspectiva do país sobre como as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente a saúde das mulheres em vulnerabilidade social.
REPÚBLICA DA POLÔNIA 	A Polônia adota uma política externa orientada pela defesa irredutível dos valores tradicionais pró-vida, sendo uma das signatárias mais ativas da Declaração de Consenso de Genebra. O país possui um histórico de oposição severa à inclusão dos termos de aborto ou de vertentes liberais dos direitos médicos femininos nas resoluções da ONU, tratando a interrupção da gravidez como uma violação do direito à vida desde a concepção. O direcionamento polonês foca na promoção de políticas de incentivo financeiro à maternidade e ao pré-natal de excelência. A delegação atua de forma coordenada com outros Estados de matriz conservadora.
REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE 	A atuação internacional do Reino Unido baseia-se no foco no empoderamento e na proteção física de mulheres, destacando-se historicamente pela criação da Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative. A abordagem britânica tende a ser pragmática, priorizando o fortalecimento dos sistemas de saúde primários e a saúde materna tradicional, mas também abrange o combate às doenças crônicas e infecciosas. No âmbito dos insumos médicos, o país apoia parcerias globais como a FP2030 (Family Planning 2030) para a distribuição de contraceptivos, mas adota uma postura de mediador para viabilizar soluções público-privadas.
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA	A Coreia do Norte pauta sua diplomacia pela defesa intransigente da soberania nacional e da não-ingêrência externa, embora seja signatária da CEDAW com reservas específicas. O discurso oficial do país apoia-se na sua Constituição Socialista e na Lei de Proteção dos Direitos das Mulheres para afirmar que o

	Estado já provê saúde universal e gratuita às suas cidadãs. Historicamente, a delegação utiliza fóruns internacionais para denunciar as sanções do Conselho de Segurança da ONU, apontando-as como as verdadeiras responsáveis por bloquear o acesso a insumos médicos vitais. O país recusa categoricamente mecanismos externos de fiscalização ou intervenções de ONGs ocidentais.
FEDERAÇÃO RUSSA 	A Rússia se posiciona como uma das principais forças de oposição ao progressismo social no sistema ONU, sendo co-autora e defensora da Declaração de Consenso de Genebra sobre a Saúde da Mulher e o Fortalecimento da Família. O arcabouço diplomático russo nega a existência de um direito internacional ao aborto e combate a inclusão de termos sobre diversidade de gênero em resoluções. O país foca sua atuação na promoção da saúde física das mulheres voltada para o estímulo à natalidade, proteção à maternidade e fortalecimento da família tradicional. A delegação costuma articular blocos com nações conservadoras para salvaguardar prerrogativas de soberania cultural.
REPÚBLICA FEDERAL DA SOMÁLIA 	A Somália participa do cenário internacional sob o impacto de um longo colapso institucional e de crises climáticas severas, operando sob o amparo de sua Constituição Provisória. O país registra índices alarmantes de mortalidade materna devido à destruição de sua infraestrutura básica de saúde por conflitos com grupos como o Al-Shabaab. O foco da diplomacia somali reside na captação de recursos emergenciais através do Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU. Em questões culturais sensíveis, como a alta incidência de MGF, o histórico do país indica a defesa de uma abordagem gradualista, baseada no diálogo religioso local, repelindo punições internacionais.
REINO DA SUÉCIA 	Como criadora histórica do conceito de política externa feminista, a Suécia possui uma longa tradição de defesa dos direitos humanos das mulheres com base na CEDAW. A diplomacia sueca apoia-se firmemente na Declaração do Cairo sobre População e Desenvolvimento para defender a autonomia corporal e o acesso irrestrito a métodos contraceptivos e ao aborto legal. O foco histórico do país reside na reestruturação de

	sistemas de saúde globais para que se tornem sensíveis ao gênero. O país atua de forma incisiva cobrando metas financeiras claras e monitoramento rígido dos compromissos internacionais assumidos pelas nações.
REPÚBLICA DA TURQUIA 	A política externa da Turquia é marcada por uma transição em direção à preservação dos valores familiares tradicionais, simbolizada pela sua histórica retirada da Convenção de Istambul em 2021. O país contesta as definições liberais ocidentais de gênero, preferindo focar o debate médico na proteção da estrutura familiar e na redução da mortalidade neonatal. Outro elemento central na história turca é o seu papel humanitário no acolhimento de milhões de refugiadas, o que faz com que a delegação utilize os princípios do Pacto Global sobre Refugiados para exigir maior compartilhamento de responsabilidade financeira internacional pelas potências globais.

8. EVENTOS E ATOS HISTÓRICOS.

Século XVIII	Surtem as primeiras formulações teóricas em defesa dos direitos das mulheres, com críticas à exclusão feminina da cidadania. Autoras como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges defendem igualdade intelectual, acesso à educação e reconhecimento político. Nesse contexto, já se evidencia a relação entre desigualdades sociais e o acesso à saúde, apontando que a exclusão feminina impacta diretamente suas condições de vida e bem-estar.
Século XIX	Consolidação de uma estrutura social patriarcal que restringe as mulheres ao espaço doméstico, limitando seu acesso à educação, política e trabalho formal. Essa exclusão também se reflete na saúde, com ausência de políticas específicas e invisibilização das necessidades femininas nos sistemas médicos.
1827 (Brasil)	A Lei Geral de Ensino garante formalmente o acesso das meninas à educação básica. Apesar de limitado, esse avanço representa um passo importante para a autonomia feminina, influenciando indiretamente melhores condições de saúde e acesso à informação.
Final do século XIX	Organização dos movimentos sufragistas na Europa e nas Américas. Além do direito ao voto, as mulheres passam a reivindicar melhores condições de vida, acesso à educação e à saúde básica, denunciando elevadas taxas de mortalidade materna e infantil.
1890	Fundação da National American Woman Suffrage Association (EUA), articulando a luta política das mulheres e ampliando debates sobre direitos sociais, incluindo a saúde.

1903	Criação da Women's Social and Political Union (Reino Unido), intensificando mobilizações públicas e consolidando a participação das mulheres na esfera política, com impactos indiretos na formulação de políticas de saúde.
Início do século XX	Ampliação das reivindicações femininas para inclusão nos sistemas de saúde. Mulheres passam a exigir atendimento digno durante a gestação e parto, além da redução da mortalidade materna e infantil. Reconhecimento gradual da educação feminina como direito essencial, sendo incentivada por reformas nacionais e por organismos internacionais. A educação passa a ser compreendida como fator determinante para a melhoria da saúde e qualidade de vida das mulheres.
1948	Criação do National Health Service (NHS) no Reino Unido, estabelecendo um sistema público de saúde. Esse modelo amplia o acesso aos serviços médicos e posteriormente incorpora políticas voltadas à saúde das mulheres. No mesmo período histórico, consolidou-se o papel de organismos internacionais na promoção da saúde como direito universal.
1960 a 1980	Segunda onda feminista amplia as pautas para incluir sexualidade, trabalho, saúde reprodutiva e desigualdades raciais. Surge a noção de que a saúde da mulher deve ser tratada de forma integral, considerando fatores sociais, culturais e econômicos. Fortalecimento das reivindicações por autonomia corporal, incluindo acesso à contracepção, planejamento familiar e debate sobre aborto seguro. Também ocorre a crítica à medicalização do corpo feminino e à redução da mulher à função reprodutiva.

1968 a 1972	Destaque para lideranças femininas negras, como Shirley Chisholm, evidenciando a interseccionalidade entre gênero, raça e acesso à saúde. Essas discussões ampliam o entendimento de que diferentes grupos de mulheres enfrentam desigualdades específicas.
1983 (Brasil)	Criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marco na política pública brasileira ao propor uma abordagem abrangente da saúde feminina, incluindo prevenção, cuidado integral e direitos reprodutivos.
1990	Fundação do European Women's Lobby (EWL), fortalecendo a articulação internacional em defesa da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres, incluindo a saúde como prioridade global.
1994	Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo) reconhece os direitos reprodutivos como parte dos direitos humanos, consolidando a saúde reprodutiva como elemento essencial da dignidade feminina.
1995	Plataforma de Ação de Pequim reforça a igualdade de gênero e a saúde das mulheres como prioridades globais, incluindo acesso a serviços de saúde, educação e autonomia reprodutiva.
Final século XX e início do século XXI	Consolidação do conceito de saúde da mulher como direito integral, abrangendo dimensões físicas, mentais e sociais. Intensificação das lutas contra violência obstétrica, desigualdades no acesso à saúde e ausência de políticas inclusivas.
Século XXI	A OMS passa a enfatizar a cobertura universal de saúde, incluindo serviços essenciais para mulheres, como pré-natal, parto seguro, cuidados pós-parto e prevenção de doenças.

	Entretanto, persistem desigualdades relacionadas a fatores econômicos, culturais e geográficos, afetando principalmente mulheres pobres, negras e indígenas.
2024	Registro de retrocessos nos direitos das mulheres em diversos países. Barreiras sociais, culturais e legais limitam o acesso à saúde básica, à contracepção e à autonomia corporal, evidenciando a permanência de desigualdades estruturais e a necessidade contínua de políticas públicas eficazes.

9. LISTA DE PAÍSES.

Estados Unidos	Avançado
Rússia	Avançado
Brasil	Avançado
Índia	Avançado
Afeganistão	Avançado
Somália	Avançado
Arábia Saudita	Avançado
China	Intermediário
Reino Unido	Intermediário
França	Intermediário
Japão	Intermediário
República Democrática da Coreia	Intermediário
Turquia	Intermediário
Mali	Intermediário
Itália	Intermediário
Canadá	Iniciante
México	Iniciante
Suécia	Iniciante
Dinamarca	Iniciante
Singapura	Iniciante

10. REFÊRENCIAS.

AMNESTY INTERNATIONAL. Sexual and reproductive rights. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: L8080. Acesso em: 29 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM): princípios e diretrizes*. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Saúde da Mulher e Linhas de Cuidado Integral na Atenção Primária*. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. *Princípios e Diretrizes do SUS: os fundamentos do sistema de saúde brasileiro*. Brasília: Ministério da Saúde, 1990. Disponível em: Princípios e Diretrizes do SUS: os fundamentos do sistema de saúde brasileiro. Acesso em: 4 maio 2026.

BRITANNICA. Audre Lorde. Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/Audre-Lorde>. Acesso em: 28 abr. 2026.

BRITANNICA. Shirley Chisholm: Biography, Accomplishments, & Facts. Disponível em: Shirley Chisholm | Biography, Accomplishments, & Facts | Britannica. Acesso em: 28 abr. 2026.

BRITANNICA. Women's Social and Political Union. *Encyclopaedia Britannica*. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Womens-Social-and-Political-Union>. Acesso em: 29 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Como o movimento de mulheres contribuiu para construção do SUS. Brasília: Cofen, 2020. Disponível em: Como o movimento de mulheres contribuiu para construção do SUS - Cofen. Acesso em: 4 maio 2026.

GN COMUNICAÇÃO E NOTÍCIAS. A revolução da saúde no Brasil: a origem do SUS e a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Disponível em: A revolução da saúde no Brasil: A origem do SUS e a 8ª Conferência Nacional de Saúde - GN Comunicação e Notícias. Acesso em: 5 maio 2026.

JMAIS. As filosofias de Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e Nísia Floresta. Disponível em: As filosofias de Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e Nísia Floresta | JMais. Acesso em: 29 abr. 2026.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). 117 anos da luta das mulheres pelo direito ao voto no mundo. São Paulo: MST, 2024. Disponível em: 117 anos da luta das mulheres pelo direito ao voto no mundo - MST. Acesso em: 5 maio 2026.

NCD ALLIANCE; TASK FORCE ON WOMEN AND NCDs. *Women and Noncommunicable Diseases: a call to action*. Relatório técnico sobre DCNTs e gênero em países de média e baixa renda, 2023.

ONU MULHERES. Um em cada quatro países relata retrocesso nos direitos das mulheres em 2024. Nova Iorque: ONU Mulheres, 2024. Disponível em: Um em cada quatro países relata retrocesso nos direitos das mulheres em 2024 - ONU Mulheres. Acesso em: 29 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Declaração e Plataforma de Ação de Pequim*. Pequim: Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, 1995. Disponível em: <https://www.unwomen.org/>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivo 3 — Saúde e Bem-Estar*. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Estratégia global da OMS para acelerar a eliminação do cancro do colo do útero como problema de saúde pública*. Genebra: OMS, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Mortalidade materna: principais fatos*. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Violência contra as mulheres: um problema de saúde pública de proporções globais*. Genebra: OMS, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/>.

OXFORD ACADEMIC. Movimentos femininos latino-americanos: uma visão histórica. In: *Manual Oxford da Sociologia da América Latina*. Oxford: Oxford University Press, 2020. Disponível em: Movimentos Femininos Latino-Americanos: Uma Visão Histórica | O Manual Oxford da Sociologia da América Latina | Oxford Acadêmico. Acesso em: 30 abr. 2026.

PETERS, S. A. E. et al. Women's health: a new global agenda. *BMJ Global Health*, v. 1, n. 3, e000080, 2016.

SILVA, J. M. J. et al. Desigualdades no acesso aos serviços de saúde na América Latina: revisão de escopo. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 5, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/jmjWdBWrqVVsbSXHdyYJHnf/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 30 abr. 2026.

THINK OLGA. *Especial Saúde das Mulheres: uma análise sobre a saúde mental e a sobrecarga do trabalho de cuidado no Brasil*. São Paulo: Lab Think Olga, 2021.

VEJA. Rússia taxa mulheres que não querem ser mães como questão de saúde que requer psicólogo. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/russia-taxa-mulheres-que-nao-querem-ser-maes-como-questao-d-e-saude-que-requer-psicologo/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*. Genebra: World Health Organization, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. Genebra: World Health Organization, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Women's Health*. Genebra: WHO, 2026. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/women-s-health>.